

T1. Sistema, contexto y visión

T1.1 Clasifique el SIGEDEFA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, softwareintensivo, adaptativo) y justifique con dos características del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.

Sistema de Información: Consolida en tiempo real transacciones críticas de ventas, inventario, lotes de 4800 productos distribuidas en ocho sucursales para la toma de decisiones gerenciales y reportes contables.

Sistema Software Intensivo: El éxito operativo, la trazabilidad legal ante entes reguladores y el cumplimiento de las metas del negocio dependen estrictamente del diseño, comportamiento y calidad del software desarrollado.

Consecuencia para la IR: Al ser un sistema de información distribuido y software intensivo, la IR debe poner especial énfasis en la completitud de las interfaces de datos, la consistencia de la concurrencia evitar rupturas de stock y el modelado riguroso de las reglas de negocio para asegurar que el sistema no corrompa los estados financieros ni de inventario.

T1.2 Defina el límite del sistema y el contexto: mencione dos elementos que quedan dentro del sistema, dos que pertenecen al contexto y uno que esté en la frontera (interfaz), justificando este último.

Dentro del sistema: El motor de base de datos centralizado y la lógica de verificación automática de alergias e interacciones medicamentosas.

Contexto del sistema: El Ente Regulador Sanitario y el Sistema Tributario.

Frontera del sistema: Pertenecer a la frontera porque es un dispositivo de hardware externo al software, pero se acopla directamente a través de una interfaz técnica definida por el requisito R-06 para capturar el peso de los preparados magistrales automáticamente en tiempo real.

T1.3 Formule la visión del sistema en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.

Proveer a la cadena Salud Total una plataforma centralizada e integrada en tiempo real que optimice la gestión de ventas e inventarios, garantice la trazabilidad de lotes y la seguridad clínica en los despachos, y asegure el cumplimiento normativo contable y sanitario en todas sus sucursales.

T1.4 Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SIGEDEFA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

Perspectiva Funcional: (D2) Interacción operativa del sistema con los usuarios durante el negocio. *Evidencia:* "En las horas pico atiendo a un cliente cada dos minutos. El sistema debe ser rápido en el despacho.

Perspectiva Normativa: (D6) Restricciones impuestas por leyes u organismos externos. *Evidencia:* "respetar la normativa local de protección de datos personales para los datos clínicos" e "imposibilidad de demostrar la trazabilidad de los lotes ante las inspecciones del ente regulador".

Perspectiva Técnica: (D6) Limitaciones del hardware y entornos donde operará el software. *Evidencia:* "ejecutarse en los equipos que ya tenemos... (Windows 10, Intel i3, 4 GB de RAM)".

T2. TIPOS DE REQUISITOS, PROCESO Y FRAMEWORK DE IR

T2.1 Clasifique las declaraciones D1 a D6 distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional, restricción y requisito de proceso (vs. requisito de producto). Una misma declaración puede contener más de un tipo; identifíquelos por separado en una tabla.

T2.2 Recomiende el modelo de proceso de requisitos (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SIGEDEFA con tres razones contextualizadas al caso (considere la exigencia explícita de demos mensuales con SCRUM y la diversidad de perfiles de usuarios).

Modelo recomendado: Modelo de Proceso Ágil

Razón 1: Existe un mandato contractual e institucional explícito por parte de la gerencia y la cooperación financiera utilizar SCRUM con entregas de demos funcionales mensuales.

Razón 2: Alta diversidad y disparidad en los perfiles de usuarios un enfoque ágil permite la validación temprana de interfaces (UI/UX) mediante prototipos evolutivos en cada Sprint.

Razón 3: Mitigación de riesgos operacionales altos (como la resistencia al cambio del Q.F. Mendoza). Las iteraciones cortas permiten recibir feedback inmediato de los usuarios en las sucursales, reduciendo el riesgo de rechazo final del sistema.

T2.3 Aplique el framework de IR: identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividad core se originó la declaración D6, a qué tipo de artefacto (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué actividad transversal debe activarse al incorporarla

Actores del proceso de IR: Analista Líder de Requisitos, Lic. Vélez, Q.F. Mendoza (Farmacéutico), Sra. Pinargote (Paciente), Dr. Quimís (Médico) y CPA Espinoza (Contadora).

Actividad Core donde se originó D6: Se originó en la actividad de Elicitación, específicamente durante la segunda reunión de levantamiento con el stakeholder.

Tipos de Artefacto en D6:

- "Ejecutarse en los equipos que ya tenemos. "Artefacto de Contexto restricción Técnica.
- "Respetar la normativa local de protección de datos." Artefacto de Requisitos, regla obligatoria de cumplimiento.

TAREAS DE LA UNIDAD 2

T3. Planificación de la elicitación

T3.1 (0,8) Construya la matriz fuente → técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (stakeholders, documentos, sistemas actuales de escritorio, normativa sanitaria y tributaria), seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada (debe usar al menos tres técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.

Fuente de Requisitos	Tipo de Fuente	Técnica Principal	Justificación según el Perfil
Dr. Quimís / Personal Médico	(Experto)	Entrevista Semiestructurada	Permite profundizar de forma guiada en criterios clínicos complejos.
Sistemas actuales de escritorio	Sistema Heredado	Arqueología de Software	Permite identificar los cuellos de botella exactos y las causas reales de los errores de facturación.
Normativa Sanitaria y Tributaria	Documentación	Análisis de Documentos	Las leyes locales y formatos del SRI/Ente Regulador son fuentes estables, ultra específicas y obligatorias que no se negocian.

T3.2 Diseñe el guion de entrevista semiestructurada al Dr. Quimís (médico prescriptor) con cinco preguntas: combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de embudo y oriéntelas a descubrir el flujo de la prescripción electrónica y los criterios clínicos de verificación de alergias e interacciones.

Objetivo: Descubrir el flujo de la receta electrónica y las reglas de validación clínica.

Preguntas abiertas.

1. ¿Podría describir detalladamente el paso a paso que realiza desde que atiende a un paciente hasta que emite y firma una receta electrónica?
2. En su experiencia médica habitual, ¿cómo maneja e identifica actualmente las alertas de alergias o interacciones de medicamentos en sus pacientes antes de recetar?
3. ¿Qué criterios clínicos específicos o bases de datos farmacológicas considera indispensables que el sistema consulte para disparar una alerta de interacción medicamentosa grave?
4. Si el sistema detecta una alergia crítica durante el despacho, ¿cuál debería ser el protocolo o la acción inmediata que el farmacéutico deba realizar en el sistema?

Pregunta Cerrada

5. Para el resguardo del historial clínico, ¿está de acuerdo en que el acceso de consulta se restrinja exclusivamente al médico prescriptor y al farmacéutico de turno mediante credenciales de doble factor? (Sí / No / Justifique)

T3.3 Proponga una técnica de apoyo (brainstorming, prototipado, KJ, mapas mentales o checklists) para abordar la resistencia del Q.F. Mendoza (no lo voy a usar bien) y describa cómo la aplicaría en una sesión concreta.

Técnica seleccionada: Prototipado

Uso en una sesión específica: En la sucursal del Q.F. Mendoza, se llevará a cabo un taller interactivo de 45 minutos durante las horas de menor afluencia. En vez de enseñarle gráficos abstractos, se le mostrará una computadora portátil con un simulador interactivo de la pantalla de despacho. Se le solicitará que simule la emisión de una receta electrónica compleja, y el procedimiento se cronometrará en tiempo real con el fin de mostrarle que el sistema nuevo no supera los dos minutos de su estándar actual.